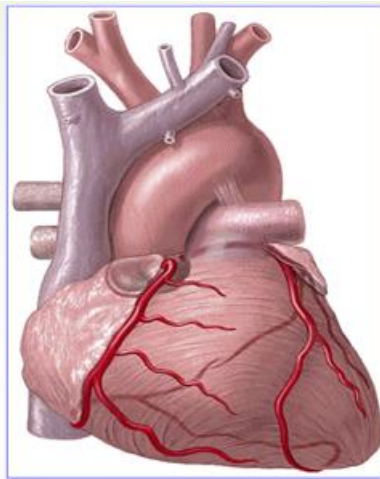




**Polycopié à l'usage des étudiants de 3^{ème} année de Médecine
Unité d'Enseignement Intégrée (UEI 1)**



« Examen cardiaque »

Pr S. HARZOUZ (Médecine interne/HMRUC)

21/01/2025

I- INTRODUCTION:

La Sémiologie Cardiaque regroupe le Recueil :

- ✓ **des Signes Fonctionnels** : → Plaintes formulées par les patients.
- ✓ **et des Signes Physiques** : → Retrouvés lors de l'examen clinique.

La prise en charge médicale impose de recueillir les **Antécédents Médicaux Personnels et Familiaux** du patient.

- ✓ de rechercher les « **Facteurs** » de **Risque** prédisposant aux **Affections Cardiaques** les plus fréquentes, de rechercher les signes d'éventuelles maladies.



II- CONDITIONS POUR L'EXAMEN CARDIAQUE :

- ✓ **Les instruments** : Stéthoscope, lampe, abaisse-langue, Montre, gants, tensiomètre, mètre ruban.
- ✓ L'examen clinique doit être fait dans une pièce calme à une température confortable.
- ✓ L'examen clinique comporte :

- **L'interrogatoire.**
- **L'inspection.**
- **La palpation.**
- **La percussion.**
- **Et l'auscultation +++.**



- ✓ Examen se fait : « position Décubitus Dorsal, Décubitus Latéral Gauche, Assise penchée en avant, debout Respiration Normale, Apnée Respiratoire et en Fin d'expiration ».
- ✓ Temps essentiel de l'examen clinique, indispensable à l'établissement d'un diagnostic.

L'interrogatoire permet :

- De déterminer le Motif de Consultation.
- De recueillir les Antécédents et le Mode de vie.
- D'établir l'Histoire de la Maladie.

« Antécédents Personnels et Familiaux »

- **Antécédents Personnels** : en trois parties :
 - Les Antécédents Cardiovasculaires.
 - Les Antécédents Médicaux.
 - Les Antécédents Chirurgicaux.
- **Et de préciser** les Hospitalisations Antérieures.



III- INTERROGATOIRE DU PATIENT :

III-A Les Antécédents Cardiovasculaires :

- ✓ Les Coronaropathies et Antécédents d'infarctus du myocarde.
- ✓ Les Valvulopathies.
- ✓ Les épisodes d'insuffisance cardiaque.
- ✓ Les Troubles de la Conduction.
- ✓ Les Troubles du Rythme.
- ✓ Les épisodes de Thrombose Veineuse Profonde et/ou d'Embolie Pulmonaire.
- ✓ La présence de Pathologie Vasculaire « l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI).
- ✓ Les autres Cardiopathies.
- ✓ Les autres Antécédents Médicaux et Chirurgicaux.

III-B Antécédents Familiaux :

Tous les antécédents familiaux sont recherchés, particulièrement ceux de **Maladies Cardiovasculaires Athéromateuses**.

- ✓ L'artériopathie Oblitérante des Membres.
- ✓ La Coronaropathie.
- ✓ L'Accident ischémique Cérébral.
- ✓ **Précoces (moins de 55 ans pour l'homme, 65 ans pour la femme).**
- ✓ Chez des parents du premier degré (**père, mère, frère, sœur**).

III-C Facteurs de Risque de risque cardio-vasculaires :

Ce sont des situations qui vont exposer le patient au risque de développer un événement cardio vasculaire en plus par rapport aux autres individus de la population générale.

- ✓ **L'âge supérieur à 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme.**
- ✓ **Le sexe masculin.**
- ✓ **L'Hypertension Artérielle**
- ✓ **Le Diabète**
- ✓ **Le Tabagisme avec l'âge de début, l'âge de fin, le nombre de paquets-années ainsi qu'un sevrage inférieur à trois ans.**
- ✓ **La dyslipidémie, le traitement pris.**
- ✓ **L'hérédité cardiovasculaire : infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 55 ans chez le père ou un parent du premier degré de sexe masculin ; ou infarctus du myocarde ou mort subite avant l'âge de 65 ans chez la mère ou un parent du premier degré de sexe féminin.**
- ✓ **L'obésité : IMC (indice de masse corporelle) > 30 kg/m² (surpoids : IMC > 25kg / m²).**
- ✓ **La sédentarité.**

IV-PRINCIPAUX SIGNES FONCTIONNELS CARDIOVASCULAIRES :

Les **Symptômes Fonctionnels Cardiaques** les plus Fréquents sont :

- ✓ **Les Douleurs Thoraciques.**
- ✓ **La Dyspnée.**
- ✓ **Les Pertes de Connaissance : les Lipothymies, Syncopes.**
- ✓ **La Claudication intermittente des Membres inférieurs.**

Il faut également rechercher la présence **d'une Toux** et **d'épisodes d'Hémoptysie**.

IV- A Les Douleurs :

- ✓ **Les Douleurs Thoraciques** sont étudiées en détail dans le Cours « les Douleurs Thoraciques ».
- ✓ Et **les Douleurs Vasculaires** dans le Cours « Sémiologie vasculaire ».

Caractéristiques Des Douleurs Thoraciques ou Vasculaires :

- ✓ Circonstances d'apparition, Siège.
- ✓ Type Facteurs aggravants, Facteurs apaisants.

- ✓ Irradiation/migration, Durée.
- ✓ Fréquence de survenue.
- ✓ Signes associés.

IV- B La Dyspnée :

C'est la **perception consciente d'une gêne respiratoire**, une sensation de manque d'air avec essoufflement. Étudiée en détail dans le Cours « les Dyspnée ».

IV-C Les Palpitations, les Malaises :

C'est la **perception anormale et déplaisante des battements cardiaques** ressentis plus forts et/ou plus rapides, anormalement puissants.

Étudiés en détail dans le Cours « les Palpitations ».

IV-D Les Pertes de Connaissance : les Lipothymies, Syncopes » :

La **Syncope** est une perte de connaissance subite de brève durée due à une baisse transitoire du débit sanguin cérébral.

La **Lipothymie** est un malaise sans réelle perte de connaissance.

Étudiée en détail dans le Cours « les Syncopes ».

IV-E La Claudication intermittente des Membres inférieurs :

C'est une **Douleur** due à l'insuffisance artérielle au niveau des membres inférieurs. C'est une douleur ischémique. Les artères des membres inférieurs étant sténosées, il en résulte une diminution de l'apport sanguin, A l'effort, il y a un déséquilibre entre l'apport et les besoins.

Étudiée en détail dans le Cours « Sémiologie Vasculaire ».

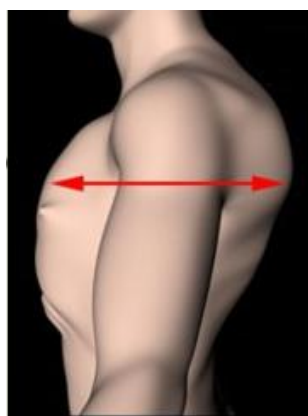
V- EXAMEN DU PATIENT : RECUEIL DES SIGNES PHYSIQUES »

V-1 Inspection :

Chez le **Sujet Normal**, l'examen de la Région précordiale ne montre rien.

L'inspection du thorax peut occasionnellement fournir des informations utiles :

A- Morphologie : thorax « en tonneau » des insuffisants respiratoires, thorax « en entonnoir » (*pectus excavatum*), cypho-scoliose.



thorax en tonneau



thorax en entonnoir



cyphoscoliose.

- ✓ **Présence de Cicatrices**, notamment de chirurgie cardiaque ou vasculaire.
- ✓ **circulation veineuse collatérale**, œdème « en pèlerine ».

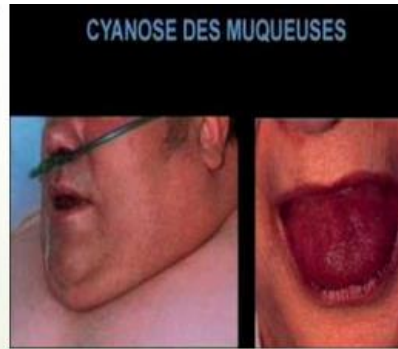
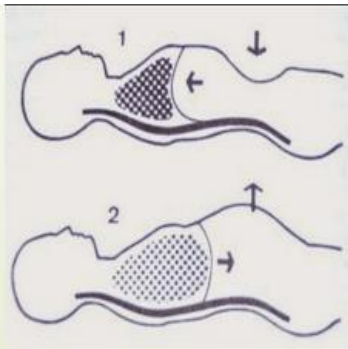


Cicatrice de chirurgie cardiaque



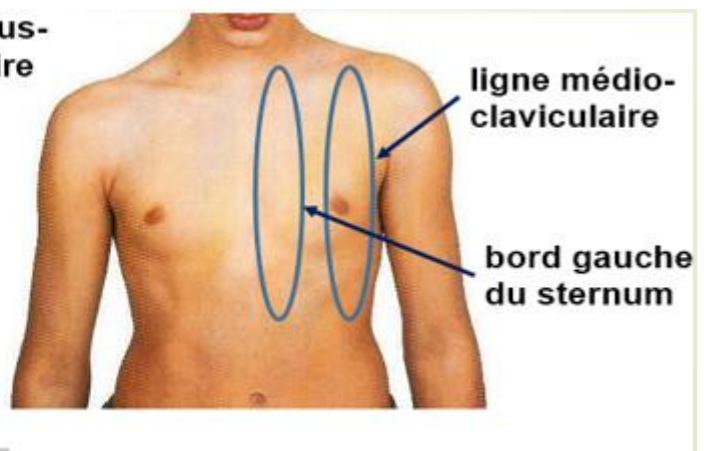
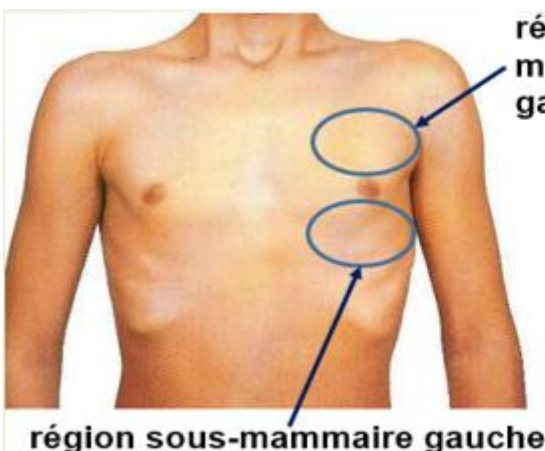
B- Fréquence Respiratoire :

- ✓ Normale < 15/min au repos chez l'adulte.
- ✓ **Qualité de la Respiration (pénibilité, régularité)** : dyspnée de repos, orthopnée, **une polypnée** (fréquence respiratoire > 20/min).
- ✓ **Un Tirage sus-claviculaire, une Respiration Abdominale, une Cyanose** voire un épuisement respiratoire avec **une Bradypnée**.



Recherche de **Pulsations Visibles** :

- ✓ **A gauche de la ligne médio-claviculaire**, suggèrent une Dilatation du Cœur Gauche.
- ✓ **Le long du bord gauche du sternum**, plaident pour une Dilatation du cœur droit.
- ✓ **Un soulèvement de la paroi thoracique**, synchrone du pouls, dans la **région sus-mammaire gauche**, peut témoigner d'un anévrisme pariétal du ventricule gauche.

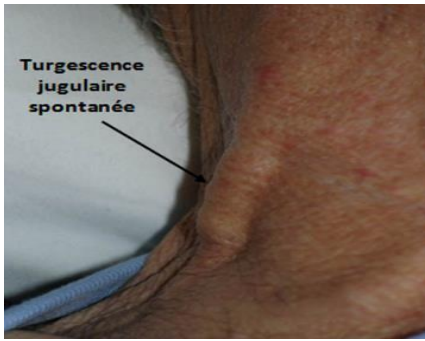


Signes d'insuffisance Cardiaque Droite :

- ✓ Turgescence jugulaire.
- ✓ Les œdèmes des membres inférieurs :
 - Blancs et parfois rouge et douloureux.

- Mous.
- Bilatéraux.
- Prenant le godet et parfois douloureux en cas de congestion.

Situés préférentiellement au niveau des chevilles et en effaçant les reliefs naturels.



V-2 Palpation :

V-2-1 Palpation thoracique :

La palpation, réalisée avec des mains réchauffées, permet de rechercher :

- A- **Le choc de la pointe du cœur.**
- B- **Les Frémissements** chez certains patients atteints de valvulopathies.
- C- Et de recueillir **des signes d'insuffisance cardiaque.**

1- Comment Rechercher le choc de pointe ?

- ✓ Il est localisé au niveau du **cinquième espace intercostal gauche.**
- ✓ Au niveau de la **ligne médioclaviculaire.**

Mieux perçu sur un sujet en décubitus latéral gauche.



Variations pathologiques du choc de pointe :

- ✓ **Diminution ou disparition :**
 - Obésité.
 - Emphysème.
 - Épanchement péricardique.
 - Insuffisance cardiaque.
- ✓ **Augmentation d'intensité :** fièvre, hyperthyroïdie.
- ✓ **Globuleux en dôme de bard :** insuffisance Aortique.
- ✓ **En cas de Cardiomégalie,** le choc de pointe est dévié en bas et en dehors (à gauche).

2- Les Frémissements sont la traduction tactile des Souffles.

- ✓ Ils ont une très grande valeur lorsqu'ils sont nets et prolongés.
- ✓ L'exemple du frémissement au cours du **Rétrécissement Mitral (RM).**



Palpation d'un frémissement
ou d'une pulsation

3- **Signe de Harzer** : perception des battements cardiaques au niveau de la région sous xiphoïdienne, témoin d'une **Hypertrophie du Ventricule Droit**.

► Un signe inconstant observé dans l'**insuffisance Cardiaque Droite**.



V-2-2 Palpation abdominale :

La palpation abdominale recherche :

- ✓ **Une Hépatomégalie.**
- ✓ **Et le Reflux Hépatojugulaire.**

Deux signes d'insuffisance Cardiaque Droite.

- ✓ **Le Reflux Hépatojugulaire** se recherche chez un patient en position demi-assise, à 45°.
- ✓ Le malade respire normalement.
- ✓ La palpation effectuée au niveau de l'hypochondre droit entraîne le remplissage des veines jugulaires pendant le temps de la compression et quelques secondes après.



V-3 Percussion :

La **percussion** est réalisée en tapant avec l'extrémité du majeur de la main droite sur les doigts de la main gauche (en général au niveau de la deuxième phalange du majeur) placée à plat sur le thorax du patient.

- ✓ Elle est peu utile pour l'examen du cœur.
- ✓ Très utilisée au niveau **pleuropulmonaire** pour rechercher des épanchements liquidiens ou aériques.
- ✓ La **Percussion Abdominale** permet de rechercher une **Hépatomégalie** ou une **Ascite** au cours d'une insuffisance cardiaque.



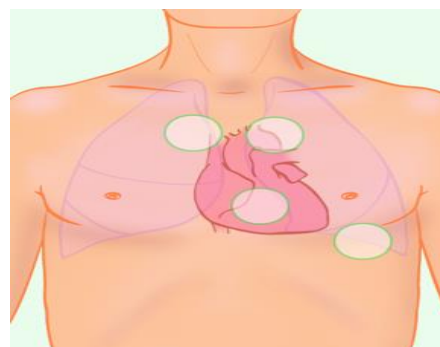
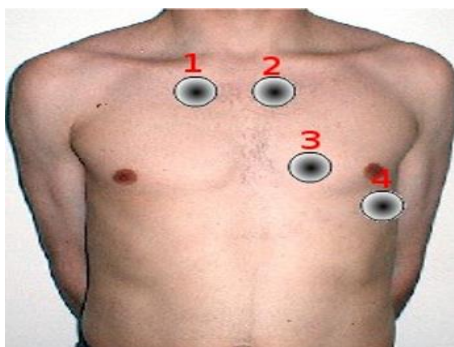
V-4 Auscultation Cardiaque :

- ✓ Le Temps essentiel de l'examen cardiaque.
- ✓ L'auscultation se fait dans une pièce silencieuse, le patient bien installé, ou le thorax facilement accessible.
- ✓ Le **Stéthoscope Biauriculaire** doit être de bonne qualité.
- ✓ Le patient doit être ausculté en décubitus dorsal, puis latéral gauche, puis en position debout, thorax penché en avant...

V-4-1 Les Foyers d'auscultation :

Les foyers d'auscultation ne correspondent pas à la situation anatomique des valvules correspondantes.

- **Le Foyer Aortique** : 2^{ème} espace intercostal droit (**Position 1**)
- **Le Foyer Pulmonaire** : 2^{ème} espace intercostal gauche (**Position 2**)
- **Le Foyer Tricuspide** : 4^{ème} espace intercostal gauche à sa partie interne (adjacente au sternum, (**Position 3**))
- **Le Foyer Mitral** : apex 5^{em} EICG en sous mamelonnaire. (**Position 4**)



V-4-2 Auscultation Cardiaque :

- ✓ **Foyer mitral** : mieux entendu en DLG.
- ✓ **Foyer aortique** : mieux entendu en position assise penchée en avant.
- ✓ **Foyer pulmonaire foyer tricuspid** : mieux entendu en inspiration profonde.

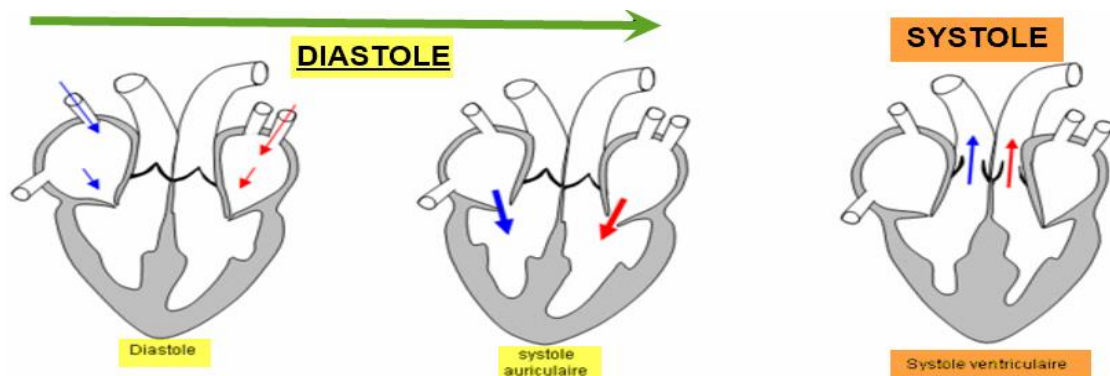
L'auscultation ne se limite pas à ces seules régions.

- ✓ **Des données importantes** peuvent être recueillies à d'autres niveaux : les zones intermédiaires, la région para sternale droite, le cou (**propagation des souffles aortiques**), la région axillaire (**propagation des souffles mitraux**)

V-4-2-1 Auscultation Normale :

Le régime Hémodynamique du cœur marqué par le jeu des variations de pression dans les différentes cavités, détermine les ouvertures et fermetures valvulaires.

- ✓ Ce sont les **Fermetures** qui engendrent les **2 Bruits Normaux du cœur B1 et B2**.
- ✓ Le B1 et le B2, dont le bruit est équivalent au « POUM-TA ».



- **Le Premier Bruit, ou B1** : correspond à la **Fermeture des valves auriculo-ventriculaires** mitrale (B1M) et tricuspid (B1T) lors de la contraction du myocarde **au début de la systole ventriculaire**, de tonalité grave, maximum à la pointe.
- **Le Deuxième Bruit, ou B2** : correspond à la **Fermeture des valves sigmoïdes aortique (B2A) et pulmonaire (B2P)**. Il est de tonalité plus haute que le B1, plus sec, maximum à la base.
- ✓ Le B1 marque le début de la **Systole Ventriculaire**.
- Et le B2 marque le début de la **Diastole Ventriculaire**.
- **L'intervalle B1-B2** (« petit silence ») délimite la **Systole Ventriculaire**
- Et l'**intervalle B2-B1** (« grand silence ») la **Diastole Ventriculaire**.
- **En Fonction de B1 et B2**, on individualise plusieurs phases du cycle cardiaque qui serviront à la **Description des Anomalies Auscultatoires** :
 - ✓ Protosystolique (en début de systole).
 - ✓ Mésosystolique (en milieu de systole).
 - ✓ Télésystolique (en fin de systole).
 - ✓ Holosystolique (toute la durée de la systole).
 - ✓ et de la même façon, Protodiastolique, Méso diastolique, Télédiastolique, Holodiastolique.
- ❖ **Dédoublement physiologique du Deuxième bruit** : Ce deuxième bruit se dédouble à l'inspiration chez le sujet normal. Il est particulièrement audible, au foyer pulmonaire, chez l'adolescent ou l'adulte jeune.
- ❖ **Le B3 physiologique** Chez environ **1/3 des sujets normaux âgés de moins de 16 ans** et exceptionnellement après 30 ans, on peut entendre au début du grand silence un troisième bruit physiologique, ou B3 très sourd, peu intense entendu à la pointe (simule un dédoublement du B2).
 - Il correspond à la **phase de remplissage rapide initiale du ventricule gauche**.
 - **Ce rythme à trois temps** disparaît en Orthostatisme.
 - **L'Auscultation Pathologique** étudiée en détail dans les Cours